血小板聚集时相	第一聚集时相	第二聚集时相
速度	迅速	缓慢
是否解聚	可逆 ← 和致聚剂的浓度有关 →	不可逆
致聚剂	低浓度 ADP 等	**高浓度 ADP、血栓烷 TXA_2** 第二聚集时相主要是由**血小板**被外源性致聚剂活化后释放**内源性 ADP** 所致

外源性致聚剂 + → 血小板活化 → 内源性ADP

动脉血流速度快,血小板跟不上容易析出

串：抗血小板聚集治疗冠心病

患者的肠道不耐受阿司匹林时,可以换吲哚布芬

阿司匹林、吲哚布芬	**抑制环氧化酶（环氧合酶）COX-1→TXA_2↓**阿姨
氯吡格雷、替格瑞洛	**拮抗 ADP 受体** 2 个格格
阿昔单抗、替罗非班	**拮抗血小板 GPIIb/IIIa 受体**阿昔替我上班　三心二意聚精无力
前列环素、双嘧达莫	血小板内 cAMP↑2 个嬛嬛
利多格雷 ttsx	抑制 TXA_2 合成酶扫雷玩-扫血栓玩　对比阿司匹林:通过抑制COX-1,让TXA_2减少

血栓烷

3.释放

临时合成后释放	**TXA_2：促进血小板聚集、血管收缩**
致密体释放	ADP、ATP、5-HT、Ca^{2+}放屁、色魔、gay 都是秘密
α-颗粒释放	血小板因子 **PF_4**、β 血小板球蛋白等：促进血液凝固、了解血小板**活化**火拼 F_4　提供磷脂表面吸附凝血因子

血小板聚集后促进 ADP、TXA_2 等释放，ADP、TXA_2 又促进血小板不可逆聚集——释放聚集、聚集释放（正反馈）

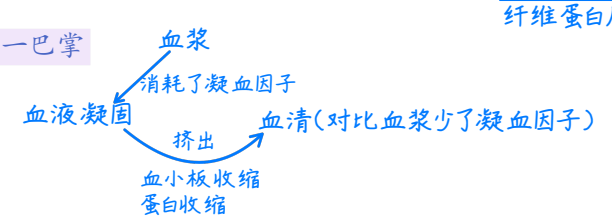
4.收缩

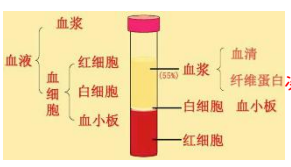
①血小板数量减少导致血凝块回缩不良，因此**原发免疫性血小板减少症 ITP 患者血凝块回缩不良、出血（血小板不能保持血管内皮完整性）**

②血小板 GPIIb/IIIa 异常也导致血凝块回缩不良，因此**血小板无力症影响聚集和收缩**　不仅影响聚集也会影响收缩

③**血小板收缩蛋白收缩**→血凝块回缩→挤出血清→血凝块变得更坚实：血清相较血浆多了血小板释放的 ADP、TXA_2 等，但**血清少了被消耗的凝血因子** 1、2、5、8、13　小豪是个十　纤维蛋白原

三点打我儿一巴掌





凝血因子

5.吸附：血小板因子 PF 是血小板表面的磷脂酰丝氨酸，可提供磷脂表面吸附凝血因子